

El trámite como barrera

La única razón de no consulta que crece, y por qué parece castigar a los ricos

Daniel A. Garavito Jiménez

Economista de la salud. Procesamiento propio de los microdatos anonimizados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (DANE), trece rondas 2012–2025.

«No hay nada tan permanente como una solución temporal.»

Atribuido a Milton Friedman, aunque no aparece en ninguno de sus textos publicados — lo cual, tratándose de trámites que nadie recuerda haber creado, resulta apropiado.

De las cinco razones por las que un colombiano que se enfermó no llega a consultar, cuatro llevan siete años quietas. Una sube todos los años.

Esa es la columna. El resto es el detalle.

El dato, y de dónde sale

La Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE le pregunta cada año a los hogares —235.350 personas en 2025— si tuvieron un problema de salud en los últimos treinta días, si recibieron atención médica, y si no la recibieron, por qué. Esa última pregunta tiene trece opciones de respuesta y es la que convierte un indicador de acceso en un diagnóstico de política, porque distingue una falla de plata de una de distancia o de una de oferta.

Dos de esas trece opciones describen la misma cosa: «muchos trámites para la cita» y «no le cubrían o no le autorizaron la atención». Juntas forman lo que aquí llamo la **barrera de trámite**.

En 2025, el **6,5 %** de quienes no recibieron atención lo atribuyó a esa barrera. En el nivel prepandémico —el promedio de 2018 y 2019, los dos únicos años anteriores a la pandemia que comparten el diseño muestral vigente— era 3,9 %. Son 2,6 puntos porcentuales de diferencia.

Pero el nivel de un año no es el hallazgo. El hallazgo es la pendiente.

Una tendencia, y solo una

Ajustando una recta a los seis años del diseño muestral vigente y dejando fuera los dos años de pandemia, la barrera de trámite sube **0,44 puntos porcentuales por año**. El coeficiente de determinación —el R^2 , que mide qué proporción del movimiento de la serie explica la recta— es 0,89. En una serie de seis puntos anuales, eso es un alineamiento notable.

Ahora el contraste, que es lo que hace el resultado algo más que un dato aislado. La misma regresión aplicada a las otras cuatro razones:

- Barrera de oferta —mal servicio, cita muy distanciada, no lo atendieron, lo hacen esperar mucho—: +0,54 puntos por año, pero con tanta dispersión que la pendiente no se distingue de cero.
- Barrera financiera —falta de dinero—: -0,17 por año. Tampoco se distingue de cero.

- Barrera geográfica —el centro queda lejos, dificultad para viajar—: -0,13. Tampoco.
- Todas las razones imputables al sistema, agregadas: +0,67. Tampoco.

Conviene ser preciso sobre qué significa «no se distingue de cero», porque es la frase más maltratada de la estadística aplicada. **No significa que la pendiente sea cero.** Significa que con estos datos no se puede descartar que lo sea. Con seis observaciones anuales la prueba tiene poca potencia, y precisamente por eso llama la atención que una sola de las cinco la supere, y con holgura.

Mientras la barrera del dinero cede y la afiliación se universaliza, la del procedimiento crece. **La plata dejó de ser el obstáculo; el papeleo tomó su lugar.**

El gradiente que parece invertido

Aquí viene la parte contraintuitiva, y es la que vale la columna.

La barrera de trámite es **más** frecuente en cabecera (7,8 %) que en centro poblado y rural disperso (3,0 %). Es más frecuente entre quienes no se reconocen en un grupo étnico (7,0 %) que entre quienes sí (3,0 %). Está prácticamente ausente entre los menores: 2,0 % en niños de 0 a 9 años, 1,2 % entre 10 y 19. Y se concentra en las edades laborales, entre los 30 y los 59.

El índice de concentración —que mide en qué extremo de la distribución de ingreso se acumula un fenómeno— es levemente **positivo**. Es el único indicador de barrera de toda la encuesta con ese signo. Todos los demás son negativos, es decir, se concentran en los hogares pobres.

La lectura ingenua sería que el trámite castiga a los urbanos, a los adultos y a los acomodados. La lectura correcta es la contraria, y se sigue de cómo está construida la pregunta.

La firma de una cola

El indicador se calcula **entre quienes no recibieron atención**, y esas personas se reparten la totalidad de las razones: si una crece, las demás bajan por aritmética. Solo reporta «trámite» quien llegó lo bastante lejos como para toparse con el trámite.

Un niño de siete años en un centro poblado cuyo hogar no consultó porque el centro de atención queda lejos nunca llega a la ventanilla de autorización. Su hogar reporta «distancia». No reporta «trámite», y no porque no haya trámites, sino porque no llegó a ellos.

Que la barrera geográfica tenga un índice de concentración de -0,109 —fuertemente cargada hacia los pobres— y la de trámite lo tenga positivo no describe dos poblaciones con problemas distintos. **Describe dos estaciones del mismo recorrido.** A quien lo filtran temprano no aparece en el filtro tardío.

De ahí se siguen dos cosas. La primera es que este indicador es un **piso**, no una medida de la carga administrativa real: no cuenta a quien consiguió la cita después de mucho trámite —esa persona sí se atendió y sale del denominador—, ni a quien nunca llegó a solicitarla. La segunda es incómoda: a medida que la afiliación se universaliza y las barreras de entrada más gruesas ceden, más gente llega hasta la ventanilla, y la ventanilla se vuelve el cuello de botella visible.

La categoría que Europa dejó de medir

El indicador internacional de referencia para el acceso desde encuestas de hogares es la necesidad de atención médica no satisfecha de la encuesta europea EU-SILC (*European Union Statistics on Income and Living Conditions*, la encuesta armonizada de ingresos y condiciones de vida de la Unión Europea). En su revisión de 2015, EU-SILC agrupó las razones en una sola categoría de «costo, distancia o lista de espera» y dejó de preguntar por autorización administrativa.

La decisión es comprensible: en sistemas de aseguramiento único o de servicio nacional de salud, la autorización previa no es un paso frecuente para la consulta ambulatoria. En Colombia sí lo es. El SGSSS opera con un asegurador que autoriza y un prestador que atiende, y entre uno y otro hay un procedimiento que el usuario debe atravesar.

Colombia mide algo que sus países de referencia dejaron de medir. Eso no es una limitación de la comparación internacional: es una posición en ella.

El punto normativo

El artículo 6 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 incluye la accesibilidad entre los elementos esenciales del derecho fundamental a la salud, y la entiende como acceso sin barreras. Conviene, eso sí, no estirar la norma más de lo que da: el artículo 14, que suele citarse aquí, prohíbe la autorización administrativa **entre el prestador y la entidad que gestiona los servicios, y solo cuando se trata de atención de urgencia**. No cubre la consulta ambulatoria ordinaria, que es justamente lo que este indicador mide.

La distinción no es un detalle de abogado: decide qué se puede afirmar con el dato. Cuando un hogar responde que no consultó porque no le autorizaron la atención, no está probando que alguien infringió el artículo 14. Está describiendo una falla de accesibilidad —la del artículo 6, que es una obligación de resultado— medida por una fuente que no es parte interesada. Es menos espectacular y es más sólido: una obligación de resultado no se cumple con un memorando.

El punto de gestión

El 16 de octubre de 2025 el Ministerio de Salud adoptó, mediante la Resolución 2117, el Modelo de Gestión de Tiempos de Espera, y el 12 de diciembre lo puso a operar con la Circular Externa 038, que fija por primera vez estándares de referencia para la asignación de citas: tres días en medicina general, cinco en pediatría, ocho en obstetricia, diez en ginecología, psiquiatría y cirugía general, quince en medicina interna. La medición la reportan las EPS, las entidades adaptadas, las secretarías de salud y los prestadores.

El modelo es un avance real y hay que decirlo con todas las letras: por primera vez el país va a tener una línea de base de tiempos de espera. Los defensores de ese instrumento tienen razón en que sin medición no hay gestión.

Pero el modelo mide el tiempo de quien consiguió la cita. No mide a quien la pidió y desistió. Y ahí hay un problema aritmético que conviene ver antes de que produzca la conclusión equivocada: **si más gente desiste, la cola de los que quedan se acorta**. Un indicador construido así puede mejorar mientras el acceso empeora.

No hace falta cambiar el modelo. Hace falta publicarlo junto al otro.

Lo que este dato no dice

No dice que el número de trámites haya aumentado. No dice que las EPS estén negando más autorizaciones. Dice que una proporción creciente de quienes desistieron de consultar atribuye su desistimiento al trámite.

Esa proporción puede crecer porque el trámite empeora, porque las otras barreras mejoran, o porque cambia la composición de quienes desisten. Las tres explicaciones son compatibles con el dato. La encuesta son cortes transversales repetidos, no un panel: muestra **cuándo** cambia un nivel, nunca **por qué**.

Y hay que decir algo más sobre la precisión. Este indicador se estima sobre un subconjunto pequeño y muy agrupado de la muestra: su intervalo de confianza en 2025 va de 4,6 % a 9,1 %, que es ancho. La estimación del nivel de un año concreto debe citarse siempre con su intervalo. Lo que sí es robusto es la tendencia: seis puntos anuales alineados con un R^2 de 0,89 son difíciles de producir por azar.

El cierre

Fui asesor en la ADRES hasta agosto de 2026 y hoy escribo desde fuera del sistema, así que me ciño a lo que puede verificarse. Los microdatos son públicos, el procesamiento es reproducible, y las cifras de esta columna se pueden auditar una por una.

Colombia pasó treinta años resolviendo el problema de quién tiene carnet, y lo resolvió. Ahora empieza el problema de qué hace el carnet. Y lo que la encuesta muestra es que, entre todas las puertas que se le pueden cerrar a un paciente, la que se está cerrando más rápido no es la del dinero ni la de la distancia.

Es la que no cuesta nada abrir.

Referencias

- Congreso de Colombia. (2015). *Ley Estatutaria 1751 de 2015*, artículos 6 y 14. Diario Oficial 49.427.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2026). *Boletín técnico: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025*. Bogotá: DANE.
- Erreygers, G. (2009). Correcting the concentration index. *Journal of Health Economics*, 28(2), 504-515.
- Eurostat. (2018). *Methodological guidelines and description of EU-SILC target variables: unmet need for medical examination*. Luxemburgo.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2025, 12 de diciembre). *Circular Externa 038 de 2025*, Modelo de Gestión de Tiempos de Espera. Bogotá.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2025). *Resolución 2117 de 2025*. Bogotá.
- Lumley, T. (2010). *Complex surveys: A guide to analysis using R*. Hoboken: Wiley.

Descargo de responsabilidad

Las opiniones, análisis y reflexiones que publico en este espacio son exclusivamente de mi autoría y de carácter personal. Fui Asesor de Innovación y Analítica de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) hasta agosto de 2026; a la fecha de esta publicación no me desempeño en el sector público ni en ninguna entidad del sistema de salud. Nada de lo aquí escrito constituye posición institucional ni representa el criterio oficial de la ADRES, del Ministerio de Salud y Protección Social, ni de ninguna otra entidad del sector.

Los contenidos se elaboran a partir de (i) información de dominio público —en particular los microdatos anonimizados que el DANE publica—, (ii) literatura académica verificable debidamente citada, y (iii) experiencia profesional acumulada a lo largo de mi trayectoria. En ningún caso divulgan información reservada, datos personales de beneficiarios, datos de operación contractual, ni elementos bajo deber de confidencialidad institucional.

Cuando discuto mecanismos de política pública, metodologías técnicas o desafíos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo hago en mi calidad de ciudadano y profesional del sector, con el ánimo de aportar al debate público informado. Las propuestas que formulo son hipótesis de discusión, no compromisos institucionales.

Quien desee la posición oficial de la ADRES sobre cualquier tema puede consultar sus canales institucionales en www.adres.gov.co.

El procesamiento que sustenta las cifras de esta columna es reproducible y está documentado en el documento de trabajo correspondiente de la serie. Esta versión es un borrador sometido a revisión externa: se agradece cualquier corrección.

Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente a su autor y no comprometen la línea editorial de CONSULTORSALUD.